

PNEUMOLOGIE & CHIRURGIE THORACIQUE

Fiches QE Haute Fréquence – S6 Pathologie respiratoire – Version 1

*Cross-match : 699 QEs officielles (2018→2025) × Cours AIO Respiratoire
(respiratoire-aio.pdf)*

FMPM – Concours 2026 • Médecine + Chirurgie thoracique • 14 sessions (Mai 2018 → Juin 2025)

PARTIE 1 – CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 699 QEs (14 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES DIFFUSES (PID)	65 Q	–
2	LES PLEURÉSIES	58 Q	–
3	BPCO	54 Q	–
4	PNEUMOTHORAX	53 Q	Chirurgie
5	ASTHME	50 Q	–
6	DILATATION DES BRONCHES (DDB)	42 Q	–
7	LES TRAUMATISMES THORACIQUES	41 Q	Chirurgie
8	INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGUË	35 Q	–
9	TUMEURS MÉDIASTINALES	34 Q	–
10	CANCER BRONCHIQUE	33 Q	–
11	KYSTE HYDATIQUE PULMONAIRE (KHP)	31 Q	–
12	ABCÈS PULMONAIRE	28 Q	–
13	PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE	27 Q	–
14	INFECTIONS RESPIRATOIRES BASSES COMMUNAUTAIRES (IRABC)	21 Q	–
15	TUBERCULOSES AIGUËS	19 Q	–
16	SYNDROME D'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL (SAOS)	19 Q	–
17	TUBERCULOSE PULMONAIRE COMMUNE	15 Q	–
18	PATHOLOGIE DU TABAC	14 Q	–
19	LA SARCOÏDOSE	14 Q	–
20	MYCOSES RESPIRATOIRES (ASPERGILLOSE)	13 Q	–
21	INFECTIONS RESPIRATOIRES AU COURS DU VIH	12 Q	–

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
22	PNEUMOCONIOSES	7 Q	—
23	PNEUMOPATHIE D'HYPERSENSIBILITÉ (AAE)	6 Q	—
24	HYPERTENSION PULMONAIRE (HTP)	2 Q	—

PARTIE 2 – MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 14 sessions, chaque examen ~49.9 questions.

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'examen
PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES DIFFUSES (PID)	65	4.64	9.3%
LES PLEURÉSIES	58	4.14	8.3%
BPCO	54	3.86	7.7%
PNEUMOTHORAX	53	3.79	7.6%
ASTHME	50	3.57	7.2%
DILATATION DES BRONCHES (DDB)	42	3.00	6.0%
LES TRAUMATISMES THORACIQUES	41	2.93	5.9%
INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGÜE	35	2.50	5.0%
TUMEURS MÉDIASTINALES	34	2.43	4.9%
CANCER BRONCHIQUE	33	2.36	4.7%
KYSTE HYDATIQUE PULMONAIRE (KHP)	31	2.21	4.4%
ABCÈS PULMONAIRE	28	2.00	4.0%
PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE	27	1.93	3.9%
INFECTIONS RESPIRATOIRES BASSES COMMUNAUTAIRES (IRABC)	21	1.50	3.0%
TUBERCULOSES AIGÜES	19	1.36	2.7%
SYNDROME D'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL (SAOS)	19	1.36	2.7%
TUBERCULOSE PULMONAIRE COMMUNE	15	1.07	2.1%
PATHOLOGIE DU TABAC	14	1.00	2.0%
LA SARCOÏDOSE	14	1.00	2.0%
MYCOSES RESPIRATOIRES (ASPERGILLOSE)	13	0.93	1.9%
INFECTIONS RESPIRATOIRES AU COURS DU VIH	12	0.86	1.7%
PNEUMOCONIOSES	7	0.50	1.0%
PNEUMOPATHIE D'HYPERSENSIBILITÉ (AAE)	6	0.43	0.9%
HYPERTENSION PULMONAIRE (HTP)	2	0.14	0.3%
Questions transversales / inclassifiables	6	0.43	0.9%
TOTAL leçons officielles (24) + transversales	699 Q	49.9	100%

PARTIE 3 – QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (▲) / source (📖) / lien cours (🔗) / citations (📌)

[RANG 1] PNEUMOPATHIES INTERSTITIELLES DIFFUSES (PID)

- • ~4.64 Q/examen (65 Q sur 14 sessions)

📖 Cadre : PID aiguës vs chroniques (>3 mois) ; classification ATS/ERS

Définition / présentation de la PID chronique :

- Groupe très hétérogène ; évolue >3 mois ; TDM thoracique HR = gold standard d'analyse des lésions
- Dyspnée = symptôme le plus fréquent ; toux souvent sèche ; signes extra-respiratoires de grande valeur d'orientation étiologique
- Enquête étiologique exhaustive nécessaire
- ▲ « évolue < 3 mois » = FAUX (c'est >3 mois pour la forme chronique)
- ▲ « le TVR est l'anomalie fonctionnelle la plus fréquente » = FAUX → c'est un TVR

📌 Vu chaque session – ex. Mai 2021 Q31, Mai 2020 Q24, Mai 2019 Q2, Juin 2019 Q32

Diagnostics à évoquer devant un tableau de PID :

- Miliaire tuberculeuse, sarcoïdose, pneumopathie d'hypersensibilité (PHS/AAE), fibrose pulmonaire idiopathique (FPI), silicose, connectivites
- ▲ ▲ Kyste hydatique = FAUX (piège récurrent quasi chaque session)
- ▲ ▲ Aspergillome = FAUX
- ▲ ▲ Tuberculose pulmonaire commune = FAUX (donne une caverne, pas une PID)

📌 Vu ~chaque session – ex. Juin 2025 Q24, Mai 2024 Q29, Juin 2023 Q29, Mai 2022 Q2

Bilan systématique de la PID :

- TDM thoracique HR ; fibroscopie bronchique + LBA ; biopsies bronchiques étagées + biopsies trans-bronchiques ; bilan immunologique ; pléthysmographie/EFR ; test de marche de 6 min ; DLCO
- ▲ ▲ Scintigraphie myocardique = FAUX
- ▲ ▲ TDM cérébrale = FAUX

📌 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q25, Mai 2024 Q30, Juin 2021 Q27, Mai 2018 Q2

Anomalie fonctionnelle ALTÉRÉE LE PLUS PRÉCOCEMENT :

- DLCO (diminution = signe le plus précoce)
- Anomalie typique installée = trouble ventilatoire restrictif (TVR) + baisse de la compliance statique + hypoxémie d'effort puis de repos (stades avancés)
- ▲ ▲ VEMS / VEMS-CVF / CV ne sont PAS les plus précoces – la DLCO l'est
- ▲ ▲ « augmentation de la compliance / élévation de la DLCO » = FAUX

📌 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q26, Mai 2024 Q31, Mai 2021 Q32, Mai 2020 Q26

Fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) – éléments en faveur :

- Survient après 50 ans ; tabac + RGO = facteurs de risque ; cas familiaux possibles ; début chronique

- Lésions en rayon de miel + bronchectasies de traction, prédominant aux bases et en sous-pleural (pattern UIP) ; hippocratisme digital fréquent ; baisse de la DLCO ; alvéolite NEUTROPHILE au LBA
- **▲ ▲ Fréquente avant 40 ans = FAUX**
- **▲ ▲ Lésions péribroncho-vasculaires = FAUX (ça oriente vers sarcoïdose)**
- **▲ ▲ Lymphocytose / verre dépoli typique au LBA = FAUX (FPI = neutrophile ; verre dépoli ≠ pattern UIP typique)**

 Vu chaque session – ex. Mai 2024 Q32, Juin 2021 Q30, Mai 2018 Q4, Juin 2025 Q27

LBA – orientation selon le type d'alvéolite :

- Alvéolite LYMPHOCYTAIRE → sarcoïdose, PHS/AAE, connectivite (stade précoce), pneumopathie médicamenteuse
- Alvéolite NEUTROPHILE → FPI, sarcoïdose au stade de fibrose
- LBA = intérêt diagnostique ET pronostique
- **▲ ▲ FPI dans l'alvéolite lymphocytaire = FAUX (FPI = neutrophile)**
- **▲ Clé discutable : Juin 2020 Q29 cote « aucun intérêt » comme vrai – erreur de clé ; le LBA a bien un intérêt dg/pronostique**

 Vu chaque session – ex. Mai 2024 Q33, Mai 2021 Q33, Mai 2020 Q27, Juin 2019 Q35

PID en rapport avec le tabac :

- FPI, pneumopathie interstitielle desquamative, histiocytose X (Langerhans), bronchiolite respiratoire avec PID
- **▲ ▲ Tuberculose pulmonaire commune = FAUX**
- **▲ ▲ PHS = FAUX (mécanisme immuno-allergique, non tabagique)**

 Vu : Septembre 2024 Q34, Juin 2023 Q39, Mai 2022 Q11

Complications des PID chroniques :

- Insuffisance respiratoire chronique, HTP + cœur pulmonaire chronique (insuffisance cardiaque droite), pneumothorax, surinfections, sur-risque de cancer du poumon
- **▲ ▲ La miliaire est une CAUSE de PID, pas une complication (clés discordantes selon sessions sur cet item)**

 Vu : Mai 2023 Q4, Mai 2019 Q5, Mai 2018 Q3

[RANG 2] LES PLEURÉSIES

– • ~4.14 Q/examen (58 Q sur 14 sessions)

 Distinction TRANSSUDAT vs EXSUDAT (critères de Light)

La ponction pleurale (épanchement liquidien) :

- Confirme le diagnostic de pleurésie ; permet une orientation étiologique ; peut être un geste thérapeutique (évacuatrice)
- Radio de thorax post-ponction systématique ; peut se compliquer de pneumothorax ; geste réalisé en RASANT LE BORD SUPÉRIEUR DE LA CÔTE INFÉRIEURE (paquet vasculo-nerveux sous-costal)
- **▲ ▲ « rase le bord inférieur de la côte inférieure » = FAUX (lèse le pédicule intercostal)**
- **▲ ▲ « geste anodin / sans complication » = FAUX**

- **▲ Contre-indication relative : troubles de l'hémostase (clés variables selon session)**

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q1, Mai 2024 Q1, Mai 2023 Q30, Mai 2021 Q1

Pleurésie TRANSSUDATIVE :

- Pauvre en protides (<25-30 g/L) ; plèvre saine ; aspect jaune clair/citrin ; origine mécanique ; biopsie pleurale NON indiquée
- Étiologies : insuffisance cardiaque, syndrome néphrotique, cirrhose / hépatopathie chronique
- **▲ ▲ Origine tuberculeuse = FAUX (la TBK donne un EXSUDAT)**
- **▲ ▲ Mésothéliome / tumeur pleurale = FAUX (exsudats)**

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q2, Mai 2024 Q4, Mai 2021 Q3, Juin 2021 Q1

Pleurésie EXSUDATIVE :

- Riche en protides (>30 g/L) ; plèvre malade ; biopsie pleurale indiquée ; peut être tuberculeuse ou tumorale
- Étiologies : tuberculose pleurale, mésothéliome, tumeur pleurale secondaire, connectivites
- Cas type Maroc : jeune, bas niveau socio-éco, exsudat séro-fibrineux protides 45 g/L → tuberculose
- **▲ ▲ Insuffisance cardiaque / syndrome néphrotique / cirrhose = FAUX (transsudats)**

📖 Vu chaque session – ex. Mai 2024 Q2, Juillet 2024 Q2, Mai 2022 Q27, Juin 2025 Q3

Pleurésie tuberculeuse – traitement :

- Antibacillaires (quadrithérapie) + ponctions évacuatrices + kinésithérapie respiratoire (prévention de la pachypleurite/symphyse)
- **▲ ▲ Antibiotiques non spécifiques = FAUX**
- **▲ ▲ Diurétiques = FAUX (c'est le traitement d'un transsudat cardiaque)**

📖 Vu : Mai 2024 Q3

Pleurésie purulente (empyème) :

- Urgence thérapeutique ; rare depuis l'ère des antibiotiques ; survient sur terrain fragile/immunodéprimé ; mesure du pH pleural capitale ; traitement dépend du stade ; PEC HOSPITALIÈRE ; antibiothérapie prolongée (4-8 sem) ; fibroscopie indiquée
- **▲ ▲ Prise en charge ambulatoire = FAUX**
- **▲ ▲ Survient sur terrain immunocompétent = FAUX**
- **▲ Clés discordantes sur « fréquente » : l'empyème est devenu RARE depuis les ATB**

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q4, Mai 2024 Q5, Mai 2023 Q33, Juin 2021 Q4

[RANG 3] BPCO

– • **~3.86 Q/examen (54 Q sur 14 sessions)**

📖 GOLD – groupes A/B/E ; mMRC ; score BODE

Facteurs de risque de la BPCO :

- Exogènes : tabac (principal), pollution atmosphérique, exposition aux biomasses (cuisson/chauffage), polluants professionnels, bas niveau socio-économique, infections respiratoires
- Endogène : déficit en alpha-1-antitrypsine
- ▲ ▲ Exposition allergénique = FAUX (c'est l'asthme)
- ▲ ▲ HTA = FAUX
- ▲ ▲ Le déficit en α 1-AT est ENDOGÈNE → faux si la question demande les FdR « exogènes »
- ▲ Clé discutable : Juin 2020 Q35 cote « exposition aux allergènes » comme seul FdR (clé erronée)

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q29, Mai 2024 Q34, Mai 2022 Q7, Mai 2018 Q9

Signes cliniques évocateurs :

- Dyspnée d'effort (sévérité = échelle mMRC) ; toux + expectoration chronique matinale ; distension thoracique / thorax en tonneau ; signe de Campbell et de Hoover ; hippocratisme digital ; TV0 non réversible sous bronchodilatateurs
- ▲ ▲ Érythème noueux = FAUX (sarcoïdose)
- ▲ ▲ Syndrome cave supérieur = FAUX (cancer/médiastin)
- ▲ ▲ TVR = FAUX (la BPCO donne un TV0)
- ▲ Clé discutable : Juin 2020 Q36 cote érythème noueux + sd cave comme vrais (erreur de clé)

📖 Vu : Mai 2023 Q10, Juin 2021 Q28, Mai 2019 Q9, Mai 2018 Q10

Définition de la bronchite chronique :

- Toux productive chronique, la plupart des jours, ≥ 3 mois/an, durant ≥ 2 années consécutives
- ▲ ▲ « 4 années consécutives » = FAUX

📖 Vu : Juin 2021 Q21, Juin 2019 Q30

Bilan de la BPCO :

- Radiographie thoracique ; spirométrie/EFR (diagnostic + sévérité) ; évaluation cardio-vasculaire ; bronchoscopie selon le contexte
- ▲ ▲ TDM cérébrale = FAUX
- ▲ ▲ Tests cutanés / dosage des IgE = FAUX (bilan d'asthme)

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q30, Mai 2024 Q35, Juin 2023 Q36, Mai 2019 Q10

Spirométrie au cours de la BPCO :

- Permet le diagnostic positif (TV0 non réversible, VEMS/CVF $< 70\%$) ; diagnostic différentiel avec l'asthme ; évalue la sévérité ; apprécie le pronostic ; guide le choix thérapeutique

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q37, Juillet 2024 Q42, Mai 2021 Q29, Juin 2019 Q29

Traitement de fond (groupe E / GOLD) & exacerbation :

- Fond groupe E : association LABA + LAMA ; bronchodilatateurs = base ; O2 longue durée au stade d'IRC
- Exacerbation : dominée par les causes infectieuses ; SABA ; O2 si hypoxémie ; VNI si hypercapnie/acidose ; déclencheurs = infection, EP, pneumothorax, mauvaise observance

- **▲ ▲ La corticothérapie inhalée n'est PAS le traitement de fond de référence de la BPCO**
- **▲ ▲ Réponse unique groupe E = LABA+LAMA (pas SABA seul, pas CSI seule)**

📖 Vu : Juin 2025 Q31, Mai 2024 Q46, Juin 2023 Q38, Mai 2020 Q38

Complications & comorbidités :

- Aiguës : exacerbation infectieuse, pneumothorax, embolie pulmonaire
- Chroniques : HTP + cœur pulmonaire chronique, IRC obstructive, emphysème
- Comorbidités : anémie, dépression, cancer bronchique, ostéoporose, cardiopathie, SAOS
- Score BODE = pronostique (BMI, Obstruction VEMS, Dyspnée mMRC, test de marche 6 min)
- **▲ ▲ Insuffisance respiratoire RESTRICTIVE = FAUX (la BPCO est obstructive)**

📖 Vu : Mai 2021 Q30, Juin 2021 Q22, Mai 2020 Q39/Q40, Mai 2018 Q11

[RANG 4] PNEUMOTHORAX

Chirurgie • ~3.79 Q/examen (53 Q sur 14 sessions)

Pneumothorax spontané PRIMAIRE (PSP) :

- Sujet jeune, longiligne, tabagique (rupture de blebs/bulles apicales) ; radio = hyperclarté avasculaire ; récurrence fréquente (~30-50%)
- Traitement selon taille/tolérance : repos + O2 (petit, bien toléré) ou exsufflation/drainage ; chirurgie réservée aux récurrences/complications
- **▲ ▲ Dû à une tuberculose pulmonaire = FAUX (ça oriente vers un PSS)**
- **▲ ▲ Chirurgie d'emblée dès le 1er épisode = FAUX pour le PSP simple**

📖 Vu : Juin 2025 Q45, Mai 2024 Q26, Mai 2020 Q50, Juin 2019 Q26

Pneumothorax spontané SECONDAIRE (PSS) :

- Complice/révèle une affection pulmonaire préexistante ; BPCO = cause la plus fréquente (aussi TBK) ; sujet plus âgé ; récurrences fréquentes
- TDM thoracique = examen de choix pour l'étiologie ; chirurgie indiquée dès le 1er épisode
- **▲ ▲ « secondaire à une plaie/traumatisme » = FAUX (ce serait un pneumothorax traumatique)**
- **▲ ▲ Récurrences exceptionnelles = FAUX**

📖 Vu : Juin 2025 Q46, Juin 2023 Q22, Mai 2020 Q49, Juin 2019 Q25

Pneumothorax SUFFOCANT (compressif) :

- Mécanisme à soupape ; tamponnade gazeuse ; déplacement médiastinal ; signes de gravité (cyanose, polypnée) ; URGENCE = exsufflation/drainage immédiat SANS attendre le scanner
- **▲ ▲ « opacité pleurale homogène » = FAUX (c'est une HYPERCLARTÉ avasculaire)**
- **▲ ▲ « attendre le scanner avant de traiter » = FAUX (urgence absolue)**

📖 Vu : Juin 2025 Q44, Mai 2023 Q29, Mai 2019 Q47

Pneumothorax CATAMÉNIAL :

- Femme jeune (20-30 ans) ; côté DROIT le plus atteint ; récurrences rythmées par les menstruations ; associé à une endométriose thoracique ; traitement des récurrences chirurgicales
- ▲ ▲ « femme > 50 ans » = FAUX
- ▲ ▲ « côté gauche » = FAUX (c'est à droite)

📖 Vu : Juin 2025 Q49, Juin 2021 Q49, Mai 2019 Q46

Signes de gravité & drainage thoracique :

- Gravité : état de choc, détresse respiratoire, polypnée >30, cyanose, respiration paradoxale
- Drain dans la CAVITÉ PLEURALE ; uni- ou bilatéral ; surveillance quotidienne (peau, fixation, bullage, intégrité du système, radio) ; évacue air/liquide ; raccordement à un système collecteur obligatoire ; drain de Joly/Monod ; voies axillaire ou antérieure (2e EIC médio-claviculaire)
- ▲ ▲ Drain « dans le poumon / le médiastin » = FAUX
- ▲ ▲ « exclusivement axillaire » = FAUX
- ▲ ▲ Raccordement au collecteur « facultatif » = FAUX

📖 Vu : Mai 2024 Q25, Juillet 2024 Q22/Q26, Mai 2019 Q50, Mai 2018 Q48

Indications chirurgicales & traitement des récurrences :

- Récurrence homolatérale ; 1er épisode contralatéral ; fuite aérienne prolongée ; récurrence immédiate à l'ablation du drain ; PSS ; pneumothorax chronique ou à bascule
- Récurrence : drainage itératif, thoracotomie/thoracoscopie (VATS), abrasion/avivement pleural, pleurectomie, résection des blebs, symphyse ; chirurgie = traitement le plus efficace
- ▲ ▲ Pleurectomie = ablation de la plèvre PARIÉTALE (et non viscérale – piège récurrent)

📖 Vu : Mai 2024 Q27, Juillet 2024 Q24, Juin 2025 Q50, Juin 2021 Q50

[RANG 5] ASTHME

– • ~3.57 Q/examen (50 Q sur 14 sessions)

📖 GINA – paliers de traitement ; contrôle

Définition & physiopathologie :

- Maladie inflammatoire chronique multifactorielle, allergique ou non
- Mécanismes : hyperréactivité bronchique + inflammation bronchique + bronchospasme
- ▲ ▲ Déficit en alpha-1-antitrypsine = FAUX (BPCO)
- ▲ ▲ Le tabac n'est pas un mécanisme physiopathologique de l'asthme

📖 Vu : Juin 2025 Q33, Mai 2021 Q34, Juin 2021 Q23, Juin 2019 Q36

Éléments cliniques en faveur :

- Toux/sifflements nocturnes, post-exercice, après pneumallergènes/irritants ; recrudescence et périodicité des symptômes ; terrain atopique / atopie familiale ; rhinite associée
- ▲ ▲ DEP « augmenté » = FAUX (le DEP est abaissé/variable)

📖 Vu : Mai 2023 Q6, Juin 2020 Q32, Mai 2018 Q6, Juillet 2024 Q38

Diagnostic positif :

- Clinique évocatrice + TV0 RÉVERSIBLE sous bronchodilatateurs à la spirométrie (réversibilité $\geq 12\%$ et ≥ 200 mL) + test de provocation bronchique non spécifique positif (HRB)
- ⚠️ ⚠️ TV0 non réversible = FAUX (c'est la BPCO)
- ⚠️ ⚠️ TVR = FAUX
- ⚠️ ⚠️ Tests cutanés/IgE = bilan ÉTIOLOGIQUE allergologique, pas le diagnostic positif

📖 Vu : Mai 2023 Q7, Juin 2020 Q33, Mai 2018 Q7, Mai 2020 Q35

Bilan étiologique (allergologique) de certitude :

- Tests cutanés (pricks) ; dosage des IgE sériques spécifiques ; tests de provocation bronchique SPÉCIFIQUES
- Allergènes : phanères d'animaux, pollens, acariens
- ⚠️ ⚠️ Interrogatoire / NFS ne sont pas des examens « de certitude »
- ⚠️ ⚠️ Virus & tabac = facteurs déclenchants, pas des allergènes

📖 Vu : Juin 2025 Q38, Mai 2024 Q49, Mai 2019 Q15, Juin 2019 Q39

Place de la radiographie & contrôle :

- Radio : utile au bilan initial (éliminer un DD), peut montrer une distension, indiquée lors des exacerbations (pneumonie, pneumothorax) ; PAS systématique dans le suivi
- Contrôle : symptômes diurnes, nocturnes, limitation d'activité, exacerbations, fonction respiratoire (VEMS/DEP)
- ⚠️ ⚠️ Radiographie systématique dans le suivi = FAUX

📖 Vu : Mai 2024 Q36, Juin 2023 Q40, Juin 2025 Q34, Mai 2022 Q14

Asthme aigu grave & traitement :

- FdR d'AAG : mauvaise observance, déni de la maladie, VEMS $< 40\%$, tabac, arrêt récent de la corticothérapie, ATCD d'AAG/intubation
- Traitement de fond : corticothérapie INHALÉE = pierre angulaire, $\pm$ LABA selon sévérité, adapté au niveau de contrôle, tiotropium au palier 4, éducation thérapeutique indispensable ; crise = SABA (salbutamol)
- ⚠️ ⚠️ CSI « non recommandée comme traitement de fond » = FAUX

📖 Vu : Juillet 2024 Q48, Mai 2023 Q8, Mai 2019 Q16, Mai 2020 Q37

[RANG 6] DILATATION DES BRONCHES (DDB)

– • ~3.00 Q/examen (42 Q sur 14 sessions)

Étiologies CONGÉNITALES :

- Mucoviscidose ; dyskinésie ciliaire primitive ; déficit immunitaire congénital
- ⚠️ ⚠️ SIDA / déficit immunitaire ACQUIS = FAUX (acquis)
- ⚠️ ⚠️ RGO = FAUX (acquis)
- ⚠️ ⚠️ Infections respiratoires de l'enfance = FAUX (acquises)

📖 Vu : Juin 2025 Q7, Mai 2024 Q8, Mai 2023 Q37, Mai 2021 Q8

Étiologies ACQUISES :

- Infections respiratoires de l'enfance ; RGO ; déficit immunitaire acquis (VIH) ; corps étranger ; abcès ; ABPA (aspergillose) ; polyarthrite rhumatoïde ; séquelles de tuberculose
- **▲ ▲ Mucoviscidose / dyskinésie ciliaire / déficit immunitaire congénital = FAUX (congénitaux)**

📖 Vu : Juillet 2024 Q7, Juin 2023 Q7, Mai 2022 Q33, Mai 2018 Q31

Bilan diagnostique :

- TDM thoracique HR = examen de RÉFÉRENCE (aspect en bague à chaton / rails) ; la TDM peut être normale dans les formes minimales
- Radio thoracique (une radio normale n'élimine PAS le diagnostic) ; EFR (retentissement) ; fibroscopie bronchique (bilan étiologique) ; ECBE
- **▲ ▲ Bronchographie = examen ABANDONNÉ / plus de routine (réponse « sauf un » récurrente)**
- **▲ ▲ Fibroscopie = examen de référence du diagnostic = FAUX (c'est la TDM HR)**

📖 Vu : Juin 2025 Q8, Mai 2023 Q36, Mai 2022 Q32, Juin 2019 Q7

Complications :

- Aiguës : hémoptysies, surinfections bronchiques, insuffisance respiratoire aiguë
- Chroniques : insuffisance cardiaque droite (cœur pulmonaire chronique), amylose rénale (AA), retard staturo-pondéral chez l'enfant, insuffisance respiratoire chronique
- **▲ Classement aigu/chronique = piège fréquent : hémoptysie & surinfection = aiguës ; amylose, IC droite, retard SP = chroniques**

📖 Vu : Juin 2025 Q9, Mai 2024 Q9, Juillet 2024 Q8, Mai 2023 Q38

Traitement :

- ATB si surinfection bactérienne ; kinésithérapie respiratoire pluriquotidienne (drainage) ; vaccination antigrippale + antipneumococcique ; embolisation artérielle si hémoptysie
- Chirurgie : formes LOCALISÉES compliquées (hémoptysies récidivantes/graves, suppurations à répétition)
- **▲ ▲ « toujours chirurgical » = FAUX**
- **▲ ▲ Chirurgie chez l'asymptomatique / les formes diffuses / tous les patients = FAUX**

📖 Vu : Mai 2019 Q35, Juin 2025 Q10, Mai 2024 Q10, Juin 2023 Q9

[RANG 7] LES TRAUMATISMES THORACIQUES

Chirurgie • ~2.93 Q/examen (41 Q sur 14 sessions)

Volet thoracique (flail chest) :

- ≥2 séries de fractures costales (double foyer) ; désolidarisation d'un fragment pariétal ; responsable d'une respiration paradoxale ; associé le plus souvent à une contusion pulmonaire
- Volet postérieur MOINS mobile que l'antérieur/latéral ; traitement : ventilation (stabilisation pneumatique interne) ± ostéosynthèse costale

- **▲ ▲ « une seule série de fractures » = FAUX**
- **▲ ▲ « volet postérieur plus mobile que l'antérieur » = FAUX**

📖 Vu : Juin 2025 Q43, Mai 2024 Q24, Juillet 2024 Q25, Mai 2022 Q50

Plaies thoraciques :

- Pénétrante = ouverture de la PLÈVRE ; pénétrantes ou non pénétrantes ; au Maroc fréquemment par armes blanches
- Peuvent causer : hémopneumothorax, pyothorax, chylothorax, plaie/tamponnade cardiaque, lésions abdominales associées (thoraco-abdominales)
- **▲ ▲ Pénétrante définie par l'ouverture cutanée/musculaire/péritonéale = FAUX (c'est la PLÈVRE)**

📖 Vu : Juin 2025 Q47, Mai 2024 Q28, Mai 2023 Q26, Mai 2021 Q26

Traumatismes fermés & prise en charge globale :

- Plus fréquents que les plaies ; AVP = cause la plus fréquente ; sujet jeune ; mécanismes = décélération, effet blast ; souvent dans un polytraumatisme
- PEC multidisciplinaire ; ~80% gérés par simple drainage thoracique ; chirurgie d'emblée rare
- **▲ ▲ « nécessite une chirurgie d'emblée » = FAUX (rare)**
- **▲ ▲ « atteint surtout le sujet âgé » = FAUX (sujet jeune)**

📖 Vu : Mai 2024 Q23, Juin 2023 Q26, Mai 2021 Q27, Mai 2020 Q45

Hémothorax / contusion pulmonaire / pneumomédiastin :

- Hémothorax : syndrome d'épanchement liquidien ; traité par simple drainage le plus souvent (chirurgie si massif/persistant)
- Contusion pulmonaire : 30-70% des trauma graves ; atteinte alvéolo-capillaire (œdème+sang) ; radio peu sensible les 1res heures, TDM immédiate ; pronostic grave si surinfection/SDRA ; traitement médical/ventilatoire
- Pneumomédiastin : évoque une lésion trachéo-bronchique → bronchoscopie ; peut s'accompagner d'un pneumothorax
- **▲ ▲ Hémothorax évoquant une lésion trachéale / nécessitant une bronchoscopie = FAUX (c'est le pneumomédiastin)**
- **▲ ▲ Contusion pulmonaire « traitée chirurgicalement » = FAUX**

📖 Vu : Mai 2024 Q22, Mai 2023 Q28, Mai 2020 Q48, Septembre 2024 Q46

Facteurs d'hypoxie & lésions sternales :

- Hypoxie : douleur, trouble de la mécanique ventilatoire, épanchements pleuraux, contusion pulmonaire
- Lésions sternales : signent la violence du traumatisme → rechercher une contusion myocardique ; douleur exquise à la palpation
- Fracture costale isolée : douleur exquise, traitement antalgiques + repos (pas de chirurgie, pas de respiration paradoxale)
- **▲ ▲ Épanchement péritonéal comme facteur d'hypoxie = FAUX**

📖 Vu : Mai 2023 Q25/Q27, Juin 2023 Q28, Septembre 2024 Q50

[RANG 8] INSUFFISANCE RESPIRATOIRE AIGÜE

– • ~2.50 Q/examen (35 Q sur 14 sessions)

Signes cliniques d'HYPERCAPNIE :

- Vasodilatation cutanée ; HTA ; sueurs ; astéraxis (flapping tremor) ; somnolence/troubles de conscience ; céphalées
- ⚠ ⚠ Hypotension artérielle = FAUX (l'hypercapnie donne une HTA)
- ⚠ ⚠ La cyanose traduit l'HYPOXÉMIE, pas spécifiquement l'hypercapnie

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q18, Mai 2022 Q43, Juin 2021 Q13, Mai 2019 Q38

Orientation diagnostique selon le contexte (vignettes récurrentes) :

- Post-op fracture du bassin (J3) ou post-partum (J2) + IRA → EMBOLIE PULMONAIRE
- Mollet douloureux à la dorsiflexion (Homans) + IRA → embolie pulmonaire
- Atopie + râles sibilants + IRA → asthme aigu grave
- Sujet jeune longiligne + brutal + tympanisme + ↓ vibrations vocales + ↓ murmure vésiculaire → pneumothorax

📖 Vu : Juin 2023 Q21, Mai 2020 Q12, Juin 2021 Q12, Mai 2019 Q40

IRA selon la radiographie thoracique :

- Radio NORMALE → embolie pulmonaire (avant constitution de l'infarctus), intoxication au CO, polyradiculonévrite (Guillain-Barré), asthme aigu grave
- Radio avec OPACITÉ → pneumonie, OAP, infarctus pulmonaire/atélectasie, pleurésie

📖 Vu : Juin 2020 Q21, Juin 2019 Q11, Mai 2018 Q44

IRA par obstruction des voies aériennes :

- Décompensation de BPCO ; asthme aigu grave ; (corps étranger ; tumeur sténosante)
- ⚠ ⚠ Pleurésie / fracture de côtes / pneumonie ne sont pas des obstructions des VA

📖 Vu : Juin 2019 Q10

[RANG 9] TUMEURS MÉDIASTINALES

– • ~2.43 Q/examen (34 Q sur 14 sessions)

📖 Topographie : médiastin antérieur / moyen / postérieur

Médiastin ANTÉRIEUR – corrélations clés (QCM à réponse unique) :

- + MYASTHÉNIE → THYMOME
- + GYNÉCOMASTIE ou β -HCG augmentée (hors grossesse) → CHORIOCARCINOME (tumeur germinale)
- Contenu : thymome, tératome, tumeurs germinales (séminome, choriocarcinome), goitre plongeant, lymphome, adénopathies (« les 4 T » + goitre)
- ⚠ ⚠ Neurofibrome = médiastin POSTÉRIEUR (pas antérieur)

📖 Vu chaque session – ex. Mai 2024 Q17, Juin 2023 Q17/Q18, Mai 2021 Q17, Juin 2021 Q15

Médiastin POSTÉRIEUR – corrélation clé :

- + TACHES CAFÉ AU LAIT (neurofibromatose) → NEUROFIBROME
- Contenu : tumeurs neurogènes (neurofibrome, schwannome, neuroblastome), kyste para-œsophagien
- ⚠ ⚠ Thymome / tératome / goitre = médiastin ANTÉRIEUR

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q22, Mai 2024 Q18, Mai 2023 Q49, Mai 2020 Q16

Médiastin MOYEN :

- Kyste bronchogénique, adénopathies, kyste pleuro-péricardique

📖 Vu : Juin 2021 Q14 (topographie antérieure), Juin 2020 Q16

Syndromes de compression :

- Dysphonie / paralysie d'une corde vocale → nerf RÉCURRENT (laryngé inférieur) GAUCHE
- Œdème en pèlerine + circulation collatérale → syndrome cave supérieur
- Dysphagie → compression œsophagienne ; hoquet/paralysie diaphragme → nerf phrénique
- ⚠️ ⚠️ La dysphonie n'est pas due au phrénique ni à la chaîne sympathique

📖 Vu : Mai 2021 Q19, Mai 2020 Q17, Juin 2023 Q16 (β-HCG → choriocarcinome)

[RANG 10] CANCER BRONCHIQUE

– • ~2.36 Q/examen (33 Q sur 14 sessions)

📖 TNM ; CBNPC vs CBPC

Circonstances de découverte :

- Hémoptysie ; amaigrissement ; douleur thoracique ; pneumopathie récidivante dans des territoires DIFFÉRENTS ; signes de compression locorégionale (sd cave sup, dysphonie, dysphagie, sd de Claude-Bernard-Horner = Pancoast-Tobias) ; céphalées/troubles de conscience (métastases cérébrales)

📖 Vu chaque session – ex. Mai 2022 Q15, Mai 2021 Q38, Mai 2019 Q17, Mai 2018 Q12

Syndrome de Claude-Bernard-Horner :

- Associe PTOSIS + MYOSIS + ÉNOPHTALMIE (+ anhidrose) ; traduit l'atteinte de la chaîne sympathique cervicale (tumeur de l'apex / Pancoast)
- ⚠️ ⚠️ Exophtalmie = FAUX (c'est une énophtalmie)
- ⚠️ ⚠️ Œdème en pèlerine = syndrome cave supérieur, PAS le CBH (clé Juin 2020 Q41 discutable)

📖 Vu : Juin 2020 Q41, Mai 2018 Q13

Moyens du diagnostic de CERTITUDE (histologique) :

- Bronchoscopie + biopsies (tumeurs proximales) ; biopsie scanno-guidée (tumeurs périphériques) ; biopsie d'une lésion périphérique/ganglionnaire ; écho-endoscopie bronchique (EBUS) ; biopsie d'un site métastatique ; chirurgie
- Fibroscopie : aspect macroscopique + prélèvements (biopsie du bourgeon, aspiration, brossage) ; plus rentable dans les tumeurs PROXIMALES
- ⚠️ ⚠️ Échographie abdominale = bilan d'extension, pas un moyen de certitude
- ⚠️ ⚠️ La TDM seule oriente mais ne CONFIRME pas le diagnostic

📖 Vu : Mai 2020 Q32, Juin 2020 Q42, Mai 2019 Q18, Mai 2021 Q39

Bilan d'extension / pré-thérapeutique :

- Examen clinique complet ; TDM thoracique ; échographie ou TDM abdominale ; TDM cérébrale (métastases) ; EFR/spirométrie (opérabilité) ; NFS ; (TEP-scan)

📖 Vu : Mai 2022 Q16, Mai 2021 Q40, Juin 2019 Q42, Juin 2020 Q43

Hémoptysie chez un ancien tuberculeux :

- Évoquer : rechute tuberculeuse, dilatation des bronches, aspergillome (greffe sur caverne), cancérisation sur séquelles de tuberculose
- ▲ ▲ Kyste hydatique = FAUX (clé Mai 2019 Q1)

📖 Vu : Mai 2020 Q43, Mai 2019 Q1, Mai 2022 Q1

[RANG 11] KYSTE HYDATIQUE PULMONAIRE (KHP)

– • ~2.21 Q/examen (31 Q sur 14 sessions)

Généralités / cycle parasitaire :

- Anthropozoonose (*Echinococcus granulosus*), fréquente au Maroc / pays d'élevage ; HÔTE DÉFINITIF = chien ; hôte intermédiaire = mouton ; L'HOMME est un hôte ACCIDENTEL (intermédiaire, en impasse)
- Localisation : foie = 1re localisation ; POUMON = 2e localisation chez l'adulte ; traitement essentiellement CHIRURGICAL (kystectomie/péri-kystectomie), médical (albendazole) adjuvant
- ▲ ▲ L'homme est un hôte DÉFINITIF = FAUX (piège récurrent)
- ▲ ▲ « poumon = 1re localisation chez l'adulte » = FAUX (c'est le foie)
- ▲ ▲ Traitement « surtout médical » = FAUX (chirurgical)

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q11, Mai 2024 Q11, Mai 2021 Q10, Juin 2021 Q16

Diagnostic :

- Radio thoracique = oriente (opacité ronde ; si rompu : image hydro-aérique, membrane flottante = signe du nénuphar) ; sérologie hydatique = élément important du diagnostic, quantitative/qualitative, élément de surveillance post-chirurgicale ; certitude = membranes hydatiques (vomique/fibroscopie) + sérologie positive
- ▲ ▲ NE PAS PONCTIONNER le kyste (risque de choc anaphylactique + dissémination) – piège
- ▲ ▲ « sérologie négative élimine le diagnostic » = FAUX (KHP sain souvent séronégatif)
- ▲ ▲ « sérologie toujours positive » = FAUX

📖 Vu : Juin 2021 Q17/Q18, Mai 2020 Q19, Mai 2022 Q35

KHP COMPLIQUÉ (fissuré / rompu) :

- Symptomatique ; vomique hydatique (eau de roche + membranes) ; réactions allergiques / urticaire (jusqu'à l'anaphylaxie) ; sérologie souvent POSITIVE (sensibilisation antigénique)
- ▲ ▲ « souvent asymptomatique » = FAUX (le KHP compliqué est symptomatique)
- ▲ ▲ Image en « boulet de canon » caractéristique = FAUX (les boulets de canon = métastases ; l'image du KHP rompu = nénuphar/grelot/membrane flottante)

📖 Vu : Juin 2025 Q12, Mai 2024 Q12, Juin 2023 Q11, Mai 2022 Q36

[RANG 12] ABCÈS PULMONAIRE

– • ~2.00 Q/examen (28 Q sur 14 sessions)

Abcès du poumon – caractéristiques :

- Maladie RARE (moins fréquente depuis l'ère des ATB) ; souvent d'origine BACTÉRIENNE (anaérobies++) ; survient sur terrain FRAGILE / immunodéprimé ; fibroscopie bronchique indispensable (éliminer cancer/corps étranger)
- Traitement : antibiothérapie PROLONGÉE (4-8 semaines), prise en charge hospitalière ; peut se compliquer de DDB, pyopneumothorax, hémoptysie
- ▲ ▲ « fréquent » = FAUX (rare)
- ▲ ▲ Origine virale/parasitaire (forme commune) = FAUX (bactérienne)
- ▲ ▲ Survient sur terrain immunocompétent = FAUX
- ▲ ▲ Antibiothérapie courte (7-10 j) = FAUX

📖 Vu chaque session – ex. Mai 2023 Q34, Mai 2022 Q30, Mai 2021 Q5, Mai 2018 Q27

Abcès amibien du poumon :

- Origine PARASITAIRE (Entamoeba histolytica) ; localisation BASALE DROITE (contiguïté avec l'abcès amibien du foie via le diaphragme) ; vomique brun chocolat (« pâte d'anchois ») ; rechercher des ATCD d'amibiase intestinale / abcès amibien du foie ; traitement = MÉTRONIDAZOLE
- ▲ ▲ « répond bien à l'amoxicilline » = FAUX (métronidazole)
- ▲ Clés discordantes selon session sur « droite vs gauche » et « bactérien vs parasitaire » : la médecine correcte = parasitaire, basale droite

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q6, Mai 2023 Q35, Juin 2023 Q6, Mai 2018 Q28

[RANG 13] PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE

– • ~1.93 Q/examen (27 Q sur 14 sessions)

Primo-infection tuberculeuse (PIT) :

- Souvent LATENTE/asymptomatique ; au Maroc touche surtout les ENFANTS (<15 ans) ; peut évoluer vers une tuberculose-maladie
- Diagnostic IMMUNOLOGIQUE (IDR à la tuberculine = virage tuberculinique ; IGRA)
- Signes d'une PIT patente : érythème noueux, kérato-conjonctivite phlycténulaire, tableau pseudo-typhoïdique ; complication = fistule ganglio-bronchique
- ▲ ▲ Diagnostic « bactériologique » (BK dans les expectorations) = FAUX (= TBK-maladie/commune)
- ▲ ▲ « touche surtout les adultes » = FAUX (enfants au Maroc)

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q13, Mai 2024 Q13, Mai 2023 Q41, Mai 2022 Q37

IDR à la tuberculine NÉGATIVE (anergie) :

- Immunodépression : co-infection VIH/TBK, corticothérapie/immunosuppresseurs au long cours, anti-TNFα ; sujet sain non infecté et non vacciné ; sarcoïdose ; formes graves/miliaire (anergie) ; dénutrition
- ▲ ▲ La vaccination par le BCG rend l'IDR POSITIVE → « BCG → IDR négative » = FAUX
- ▲ Attention : les clés officielles de cet item DIVERGENT fortement d'une session à l'autre (notamment sur BCG et sujet sain) – se fier à la physiopathologie : l'anergie = immunodépression / absence de contact / BCG = positivité

[RANG 14] INFECTIONS RESPIRATOIRES BASSES COMMUNAUTAIRES (IRABC)

– • ~1.50 Q/examen (21 Q sur 14 sessions)

Bronchite aiguë :

- Inflammation des BRONCHES ; origine VIRALE dans ~90% ; forme la plus fréquente des IRABC ; pas de foyer auscultatoire ; traitement SYMPTOMATIQUE
- ⚠️ ⚠️ « inflammation du parenchyme » = FAUX (c'est bronchique)
- ⚠️ ⚠️ Antibiothérapie systématique = FAUX
- ⚠️ ⚠️ Origine bactérienne 90% = FAUX

📖 Vu : Mai 2024 Q42, Juin 2023 Q48, Mai 2022 Q22

Pneumonie franche lobaire aiguë (pneumocoque) :

- Début BRUTAL ; fièvre élevée (40°) + frissons ; douleur thoracique latéralisée ; expectorations rouillées ; herpès labial ; syndrome de condensation ; opacité alvéolaire SYSTÉMATISÉE (germes : pneumocoque, Klebsiella)
- ⚠️ ⚠️ Opacité interstitielle = FAUX pour la PFLA (oriente vers atypique)

📖 Vu : Mai 2024 Q43, Juin 2023 Q49, Mai 2022 Q23, Mai 2020 Q41

Pneumonie atypique & pneumonie caséuse :

- Atypique (mycoplasme, chlamydia, virus, légionelle) : début progressif, prodrome grippal/rhinopharyngé, toux sèche, signes extra-respiratoires, opacité interstitielle, PAS d'herpès labial
- Pneumonie caséuse (vs bactérienne) : absence d'herpès labial, hyperleucocytose peu marquée, échec des ATB non spécifiques, AEG/amaigrissement
- ⚠️ ⚠️ Herpès labial fréquent dans l'atypique = FAUX (évoque le pneumocoque)

📖 Vu : Juin 2020 Q47, Juin 2019 Q44, Juin 2025 Q17, Mai 2018 Q20

COVID-19 & terrains à risque :

- COVID-19 : SARS-CoV-2 ; syndrome grippal ; PCR respiratoire = confirmation ; TDM = verre dépoli périphérique ; risque thromboembolique accru ; pronostic réservé (âge, comorbidités)
- FdR de pneumopathie grave : asplénie, diabète, VIH, tabac, corticothérapie au long cours, âge avancé

📖 Vu : Mai 2021 Q50, Juin 2021 Q37/Q38, Juin 2025 Q42

[RANG 15] TUBERCULOSES AIGÜES

– • ~1.36 Q/examen (19 Q sur 14 sessions)

Composantes de la tuberculose pulmonaire aiguë :

- Miliaire tuberculeuse ; pneumonie caséuse ; phtisie galopante (bronchopneumonie tuberculeuse)

- ▲ ▲ *Primo-infection tuberculeuse = FAUX*
- ▲ ▲ *Tuberculose pulmonaire commune = FAUX (forme chronique)*
- ▲ ▲ *Pleurésie/TBK ganglionnaire = FAUX (extra-pulmonaires/subaiguës)*

📖 Vu : Juillet 2024 Q15, Mai 2023 Q44, Mai 2022 Q40, Juin 2021 Q7

Caractéristiques & conduite :

- Entité RARE mais GRAVE ; terrain FRAGILE/immunodéprimé ; tableau d'insuffisance respiratoire aiguë ; URGENCE thérapeutique ; MAUVAIS pronostic ; traitement instauré IMMÉDIATEMENT, sans attendre la confirmation bactériologique
- ▲ ▲ *« bon pronostic » / « terrain immunocompétent » / « la plus fréquente » = FAUX*
- ▲ ▲ *« le traitement peut attendre la confirmation » = FAUX*

📖 Vu : Juin 2025 Q16, Mai 2024 Q16, Mai 2023 Q45, Juin 2023 Q15

Miliaire tuberculeuse :

- Dissémination HÉMATOGÈNE ; micronodulaire diffuse (« grains de mil ») ; tableau pseudo-typhique de Landouzy (forme généralisée) ; ponction lombaire systématique (méningite associée) ; IDR souvent négative (anergie)

📖 Vu : Mai 2018 Q35

[RANG 16] SYNDROME D'APNÉE OBSTRUCTIVE DU SOMMEIL (SAOS)

– • ~1.36 Q/examen (19 Q sur 14 sessions)

Facteurs de risque :

- Obésité ; sexe masculin ; ménopause ; macroglossie ; rétrognathisme/micrognathie ; âge ; anomalies ORL ; alcool/sédatifs

📖 Vu chaque session – ex. Mai 2024 Q39, Mai 2023 Q19, Juin 2023 Q45, Mai 2018 Q22

Symptômes :

- Nocturnes : ronflements, apnées rapportées, nycturie
- Diurnes : somnolence diurne excessive (Epworth), asthénie, céphalées matinales, troubles cognitifs/attention

📖 Vu chaque session – ex. Mai 2024 Q40, Mai 2022 Q18, Mai 2021 Q46, Juin 2020 Q50

Diagnostic, associations & traitement :

- Confirmation : polygraphie ventilatoire ou polysomnographie ; IAH (index apnée-hypopnée) >5 confirme le diagnostic
- Associations : HTA résistante, diabète de type 2, sur-risque cardiovasculaire, accidents de la voie publique ; pathologie sous-diagnostiquée
- Traitement : PPC (pression positive continue) = référence ; traitement positionnel ; orthèse d'avancée mandibulaire ; perte de poids

📖 Vu : Mai 2022 Q19, Juin 2021 Q35, Mai 2020 Q44, Mai 2019 Q23

[RANG 17] TUBERCULOSE PULMONAIRE COMMUNE

– • ~1.07 Q/examen (15 Q sur 14 sessions)

Tuberculose pulmonaire commune :

- Forme clinique de tuberculose pulmonaire LA PLUS FRÉQUENTE ; polymorphisme clinique ; à évoquer devant toute pneumopathie traînante non améliorée par une ATB non spécifique
- Diagnostic surtout BACTÉRIOLOGIQUE (BK présents dans les sécrétions bronchiques/expectorations – forme bacillifère, contagieuse ; GeneXpert/culture)
- Aspect radiologique évocateur = CAVERNE (+ infiltrats des sommets) ; peut se compliquer de DDB et de greffe aspergillaire ; traitement = antibacillaires (RHZE)
- ▲ ▲ Diagnostic « immunologique » ou « histologique » = FAUX (= immunologique pour la PIT)
- ▲ ▲ « complexe primaire » comme aspect évocateur = FAUX (c'est la primo-infection)
- ▲ ▲ « fait partie des tuberculoses aiguës » = FAUX

📖 Vu chaque session – ex. Juin 2025 Q15, Mai 2024 Q15, Mai 2021 Q14, Juin 2020 Q14

Pneumonie caséuse (en faveur) :

- Début progressif ; échec d'une antibiothérapie bien conduite ; présence de cavernes à la radiographie
- ▲ ▲ Herpès labial / hyperleucocytose franche = FAUX (orientent vers le pneumocoque)

📖 Vu : Juin 2021 Q8, Mai 2020 Q8

[RANG 18] PATHOLOGIE DU TABAC

– • ~1.00 Q/examen (14 Q sur 14 sessions)

Composants de la fumée & nicotine :

- Composants : nicotine, CO, goudrons (cancérogènes), irritants
- Nicotine = substance responsable de la DÉPENDANCE ; augmente l'acidité gastrique ; diminue le taux d'œstrogènes ; augmente les dépenses énergétiques/lipolyse ; bonne diffusion alvéolo-capillaire ; éliminée dans les urines (cotinine)
- ▲ ▲ Allergènes = FAUX (pas un composant de la fumée de tabac)

📖 Vu : Juin 2025 Q36, Mai 2021 Q43, Juin 2021 Q39, Mai 2019 Q21

Manifestations respiratoires liées au tabac :

- BPCO, emphysème, cancer bronchique ; PID liées au tabac : histiocytose langerhansienne (X), pneumopathie interstitielle desquamative, FPI, bronchiolite respiratoire avec PID
- ▲ ▲ Sarcoïdose = FAUX (non liée au tabac)
- ▲ ▲ HTA = FAUX (manifestation cardiovasculaire, non respiratoire)
- ▲ ▲ TBK commune = FAUX

📖 Vu : Juin 2025 Q32, Mai 2024 Q47, Juin 2021 Q40, Mai 2019 Q20

[RANG 19] LA SARCOÏDOSE

– • ~1.00 Q/examen (14 Q sur 14 sessions)

▢ Stades radiologiques 0-IV ; granulome épithélioïde sans nécrose

Caractéristiques générales :

- Granulomatose bénigne (granulome épithélioïde et giganto-cellulaire SANS nécrose caséuse) ; atteinte médiastino-pulmonaire FRÉQUENTE ; atteinte extra-pulmonaire fréquente
- ⚠ ⚠ « atteinte médiastino-pulmonaire rare » / « extra-pulmonaire absente » = FAUX

📖 Vu : Juin 2025 Q40, Juillet 2024 Q45, Septembre 2024 Q42

Atteinte ganglionnaire médiastinale :

- BILATÉRALE, SYMÉTRIQUE, NON compressive ; peut se calcifier (tardivement, en coquille d'œuf) ; peut s'associer à une atteinte interstitielle
- ⚠ ⚠ Unilatérale / compressive = FAUX

📖 Vu : Mai 2024 Q41, Mai 2023 Q5, Juin 2023 Q47, Juin 2021 Q32

Révélation, bilan & histologie :

- Révélation : dyspnée d'effort, toux sèche, baisse d'acuité visuelle (uvéite), arthralgies, érythème noueux, syndrome de Löfgren, découverte systématique
- Bilan systématique : TDM thoracique HR, examen ophtalmologique, radio mains/pieds, ECG, calcémie + calciurie, EFR, fibroscopie + biopsies bronchiques étagées + LBA (alvéolite lymphocytaire, rapport CD4/CD8 élevé), dosage de l'ECA
- Atteinte interstitielle : prédomine aux régions SUPÉRIEURES/moyennes
- ⚠ ⚠ Atteinte interstitielle prédominant aux bases et en sous-pleural = FAUX (ça, c'est la FPI – piège récurrent)

📖 Vu : Mai 2023 Q12, Mai 2021 Q48, Juin 2019 Q49/Q50

[RANG 20] MYCOSES RESPIRATOIRES (ASPERGILLOSE)

– • ~0.93 Q/examen (13 Q sur 14 sessions)

Aspergillome :

- Greffe aspergillaire sur cavité préexistante (séquelle de tuberculose) ; révélé par des HÉMOPTYSIES (signe principal, parfois sévères) ; image en GRELOT / croissant gazeux à la radio-TDM ; traitement essentiellement CHIRURGICAL (résection)
- ⚠ ⚠ Traitement par corticothérapie (inhalisée/orale) = FAUX

📖 Vu : Juillet 2024 Q29, Juin 2019 Q46, Mai 2018 Q24

Aspergillose pulmonaire invasive (API) :

- Atteinte aspergillaire LA PLUS FRÉQUENTE et LA PLUS REDOUTABLE chez l'immunodéprimé SÉVÈRE (neutropénie, greffe) ; causée par un champignon ; pronostic GRAVE (mortalité élevée) ; diagnostic = galactomannane + Aspergillus au LBA (signe du halo au scanner) ; traitement antifongique (voriconazole)

- ▲ ▲ « infection bactérienne » = FAUX
- ▲ ▲ Terrain atopique/asthmatique = FAUX (ça oriente vers l'ABPA)
- ▲ Clé discutable : Juin 2020 Q44 cote plusieurs réponses alors que « la plus redoutable » = API (réponse unique)

📖 Vu : Mai 2024 Q44, Mai 2023 Q17, Juin 2023 Q50, Juin 2019 Q47

Aspergillose broncho-pulmonaire allergique (ABPA) :

- Terrain : asthme difficile / mucoviscidose ; hyperéosinophilie ; DDB proximales ; IgE totales élevées + IgE/IgG spécifiques aspergillaires ; test cutané positif ; traitement = corticoïdes ± antifongique
- ▲ ▲ Élévation du galactomannane = FAUX (c'est l'API)

📖 Vu : Mai 2018 Q25

[RANG 21] INFECTIONS RESPIRATOIRES AU COURS DU VIH

– • ~0.86 Q/examen (12 Q sur 14 sessions)

Pneumocystose (Pneumocystis jirovecii) :

- Infection respiratoire LA PLUS FRÉQUENTE au cours du SIDA ; survient pour CD4 <200 ; début aigu/subaigu ; pneumopathie INTERSTITIELLE hypoxémiante ; lymphopénie profonde ; lésions kystiques → risque de pneumothorax ; traitement = cotrimoxazole (sulfaméthoxazole-triméthoprime) ± corticoïdes
- ▲ ▲ Pneumonie franche alvéolaire = FAUX (c'est interstitiel)
- ▲ ▲ « isolement de l'aspergillus au LBA » en faveur d'une pneumocystose = FAUX (clé Juin 2020 Q46 discutable)

📖 Vu : Mai 2023 Q18, Mai 2021 Q41, Mai 2020 Q29, Juin 2019 Q43

Tuberculose au cours du SIDA avancé :

- Présentation ATYPIQUE (≠ immunocompétent) ; forme MILIAIRE fréquente ; atteinte médiastinale + extrathoracique fréquente ; mycobactéries atypiques fréquentes ; coinfections à rechercher ; imagerie atypique (prédominance aux bases, peu de cavernes)
- ▲ ▲ « se manifeste comme chez l'immunocompétent » = FAUX
- ▲ ▲ « atteinte extrathoracique peu observée » = FAUX

📖 Vu : Mai 2022 Q20, Mai 2020 Q30, Mai 2019 Q25, Mai 2018 Q18

Seuils de CD4 :

- CD4 <200 → pneumocystose, toxoplasmose, tuberculose disséminée
- CD4 <100 → CMV, mycoses, mycobactéries atypiques, cryptococcose, aspergillose (immunodépression sévère)

📖 Vu : Mai 2019 Q24, Mai 2018 Q17

[RANG 22] PNEUMOCONIOSES

– • ~0.50 Q/examen (7 Q sur 14 sessions)

Silicose (inhalation de silice) – complications :

- Tuberculose (silico-tuberculose ++) ; insuffisance respiratoire chronique ; infections respiratoires à répétition ; HTP / cœur pulmonaire chronique ; masses pseudo-tumorales (fibrose massive progressive) ; adénopathies calcifiées « en coquille d'œuf »
- **▲ ▲ Lymphome = FAUX** (clé Juin 2020 Q39 discutable, cote le lymphome comme vrai – erreur)

📖 Vu : Juillet 2024 Q49, Mai 2023 Q13, Juin 2020 Q39

Exposition à l'amiante :

- Asbestose (PID/fibrose) ; cancer bronchique ; mésothéliome pleural ; plaques pleurales ; pleurésie bénigne
- **▲ ▲ Silicose = FAUX** (due à la silice, pas à l'amiante)
- **▲ ▲ Kyste hydatique = FAUX**

📖 Vu : Juillet 2024 Q50, Mai 2023 Q15, Mai 2022 Q21, Juin 2025 Q39

[RANG 23] PNEUMOPATHIE D'HYPERSENSIBILITÉ (AAE)

– • ~0.43 Q/examen (6 Q sur 14 sessions)

Maladie du poumon de fermier (PHS) :

- PHS LA PLUS FRÉQUENTE ; due à l'inhalation d'actinomycètes thermophiles du foin moisi ; granulomatose ; lymphocytose au LBA (formes précoces/aiguës) ; évolue vers la fibrose en cas d'exposition chronique
- **▲ ▲ « due aux déjections d'oiseaux » = FAUX** → ça, c'est la maladie des éleveurs d'oiseaux (autre PHS)
- **▲ Clé discutable : Juin 2020 Q28 cote « déjections d'oiseaux » comme vrai pour le poumon de fermier (erreur de clé)**

📖 Vu : Juillet 2024 Q46, Mai 2023 Q1, Juin 2020 Q28

Antigènes responsables & LBA :

- Exposition aux protéines AVIAIRES → PHS (maladie des éleveurs d'oiseaux)
- Alvéolite LYMPHOCYTAIRE au LBA → PHS, sarcoïdose, connectivite (stade précoce), pneumopathie médicamenteuse
- **▲ ▲ Protéines aviaires → FPI / BPCO = FAUX (→ PHS)**

📖 Vu : Juillet 2024 Q44, Juin 2025 Q28

[RANG 24] HYPERTENSION PULMONAIRE (HTP)

– • ~0.14 Q/examen (2 Q sur 14 sessions)

📖 Classification en 5 groupes (ESC/ERS)

HTP pré-capillaire :

- PAPm ≥ 20 mmHg ; PAPO/PCP ≤ 15 mmHg ; résistances vasculaires pulmonaires élevées ; débit cardiaque normal ou diminué ; complique les affections respiratoires chroniques (groupe 3)
- **▲ ▲ PCP > 15 mmHg = post-capillaire** (cardiopathie gauche, groupe 2)

- ⚠ *Clé discutable : Juin 2021 Q41 cote « PCP ≥ 15 » comme vrai pour le pré-capillaire (incohérent – le pré-capillaire a une PCP ≤ 15)*

📁 Vu : Juin 2021 Q41

Causes respiratoires d'HTP (groupe 3) :

- BPCO, pneumopathies interstitielles diffuses (PID), DDB, SAOS, maladies neuromusculaires / hypoventilation
- ⚠ *Clé discutable : Juin 2021 Q42 inclut l'asthme et exclut les PID – or les PID sont une cause classique d'HTP de groupe 3*

📁 Vu : Juin 2021 Q42

PARTIE 4 – TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER – À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé – NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK – BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme – tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL – HIGH-YIELD CONCOURS PNEUMOLOGIE & CHIRURGIE THORACIQUE

** CLASSIFICATIONS & SCORES À RETENIR **

BPCO	GOLD (groupes A/B/E) ; mMRC ; score BODE (pronostique)
Asthme	GINA (paliers 1-5) ; critères de contrôle
Pleurésie	Critères de Light (transsudat vs exsudat)
Sarcoïdose	Stades radiologiques 0-IV ; syndrome de Löfgren
Médiastin	Topographie antérieur / moyen / postérieur
HTP	5 groupes ESC/ERS ; PAPm ≥ 20 mmHg ; PCP ≤ 15 (pré) / >15 (post)
VIH	Seuils CD4 : <200 (pneumocystose) / <100 (CMV, mycoses, atypiques)

** MARQUEURS / CRITÈRES DISCRIMINANTS **

Marqueur / Critère	Indication
DLCO abaissée précocement	PID / FPI
TV0 réversible	ASTHME
TV0 non réversible (VEMS/CVF $<70\%$)	BPCO
Alvéolite LYMPHOCYTAIRE (LBA)	Sarcoïdose, PHS, connectivite, médicamenteuse
Alvéolite NEUTROPHILE (LBA)	FPI, sarcoïdose au stade de fibrose
Thymome + myasthénie / Choriocarcinome + β -HCG	Médiastin ANTÉRIEUR
Neurofibrome + taches café au lait	Médiastin POSTÉRIEUR
Galactomannane + Aspergillus LBA	Aspergillose pulmonaire invasive
Vomique brun chocolat + ATCD amibiase	Abcès amibien (basal droit)

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS (les FAUX récurrents) **

- ▲ PID : kyste hydatique & aspergillome ne sont PAS des diagnostics de PID.
- ▲ Ponction pleurale : rase le bord SUPÉRIEUR de la côte inférieure (et non l'inférieur).
- ▲ KHP : l'homme est hôte ACCIDENTEL (pas définitif) ; image = nénuphar/grelot (PAS « boulet de canon »).
- ▲ Pneumothorax : la pleurectomie enlève la plèvre PARIÉTALE (pas viscérale) ; suffocant = hyperclarté (pas opacité).

- ▲ *Sarcoïdose : atteinte interstitielle SUPÉRIEURE ; bases sous-pleurales = FPI.*
- ▲ *Abcès amibien : métronidazole, pas amoxicilline ; basal DROIT.*
- ▲ *TBK commune = bactériologique + caverne ; PIT = immunologique + complexe primaire.*
- ▲ *Poumon de fermier = foin moisi (actinomycètes) ; éleveurs d'oiseaux = déjections aviaires.*
- ▲ *Hypercapnie : HTA + sueurs + astéraxis (PAS hypotension ; la cyanose = hypoxémie).*
- ▲ *BCG → IDR POSITIVE (ne rend pas l'IDR négative).*

**** ENCHAÎNEMENTS & RÉFLEXES DIAGNOSTIQUES ****

- Hémoptysie chez un ancien tuberculeux → rechute TBK / DDB / aspergillome / cancérisation sur séquelles.
- Post-op ou post-partum + IRA → embolie pulmonaire.
- Jeune longiligne + brutal + tympanisme + ↓MV → pneumothorax spontané primaire.
- Pneumopathie traînante non améliorée par ATB → évoquer une tuberculose pulmonaire commune.
- Cavité séquellaire de TBK + hémoptysie + image en grelot → aspergillome → chirurgie.
- Médiastin antérieur + myasthénie → thymome ; + gynécomastie/β-HCG → choriocarcinome.
- Granulome SANS nécrose = sarcoïdose ; granulome AVEC caséum = tuberculose.

Généré par Claude.ai (claude-opus-4-8) – Version 1

Cross-match 699 QEs officielles × Cours AIO Respiratoire (respiratoire-aio.pdf)

FMPM – Concours 2026 • Médecine + Chirurgie thoracique • 14 sessions (Mai 2018 → Juin 2025)

Améliorations Version 1 :

- ✓ PARTIE 3 strictement par rang de fréquence (1 → 24)
- ✓ Déduplication des questions répétées inter-sessions (699 QE → synthèse compacte)
- ✓ FAUX explicites avec ▲ (les pièges = le contenu à plus haut rendement)
- ✓ Clés officielles douteuses signalées (« clé discutable ») avec la médecine correcte en regard
- ✓ Cross-match avec la liste officielle S6 ; les 6 QE « transversales » repliées dans les leçons concernées
- ✓ PARTIE 4 vide : aucune liste officielle d'annulations 2026 fournie – aucun cours présumé hors-programme